ICS **. ***. **
C**

团体标准

T/CACM ****－20**

冠状动脉粥样硬化性心脏病
热结血脉证临床诊断标准

Clinical diagnostic criteria on syndrome of heat retention in blood vessels in patients with coronary atherosclerotic heart disease

（文件类型：公示稿）

CACM标准公示稿

20**-**-**发布　　20**-**-**实施

中华中医药学会发布

目　次

前　言 I

引　言 II

1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　冠状动脉粥样硬化性心脏病热结血脉证临床诊断标准 2

附录A（资料性） 4

参 考 文 献 5

CACM标准公示稿

前　言

本文件按照GB/T 1.1 2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的规则起草。

本文件由中国中医科学院中医基础理论研究所提出。

本文件由中华中医药学会归口。

本文件起草单位：中国中医科学院中医基础理论研究所、河南中医药大学第一附属医院、江西中医药大学附属医院、长春中医药大学附属医院、北京市第一中西医结合医院、中国中医科学院西苑医院、福建中医药大学附属人民医院。

本文件主要起草人：胡镜清、江丽杰、许伟明、张逸雯、张佳乐、段飞。

本文件起草人：朱明军、刘中勇、邓悦、李瑞杰、赵福海、熊尚全、王传池、杨燕、林明欣、伍建光、王彦辉、张松峰、林超。

CACM标准公示稿

引　言

据《中国心血管健康与疾病报告2019》报道，我国心血管病死亡率仍居首位，高于肿瘤及其他疾病，且患病率及死亡率仍处于上升阶段。作为一种常见的心血管疾病，冠状动脉粥样硬化性心脏病（coronary atherosclerotic heart disease，以下简称冠心病）患者达1100万[1]。另根据2020版《中国卫生健康统计年鉴》[2]报道，我国城市居民冠心病死亡率为116.63/10万，农村居民冠心病死亡率为130.14/10万，且自2012年以来继续呈上升趋势。

随着社会老龄化和城市化进程加快，不健康生活方式流行，冠心病中“热”作为病因病机日渐受到重视[3-7]。本研究团队系统凝炼古今医家从“热”认识并论治心血管病的学术思想、古今医家以清热散结之法治疗血脉之疾的临床实践，梳理“热结”的概念内涵[8]，归纳提出冠心病“热结”病机辨治要点，并通过前瞻性队列研究，证实“热结”病机是冠心病稳定期患者发生心血管事件的关键。以此为基础，本团队创新提出了“热结血脉”的病机假说[9]，明确了热结血脉的概念内涵、临床表现和治法方药。但冠心病热结血脉的临床辨识尚未形成规范，既往冠心病“热”相关诊断标准存在“诊断标准未完全统一、相关术语并未规范、诊断条目缺乏权重”等问题[10]，影响其在临床和科研中的应用。

为落实《中医药标准化中长期发展规划纲要（2011-2020）》提出的“全面推进中医药标准体系建设”的重要任务，充分发挥中医药防治心血管疾病的优势，本标准在系统回顾既往冠心病热相关证诊断标准的基础上，结合既往标准研制经验[11-15]，开展多轮研讨与论证，确立了冠心病热结血脉证临床诊断条目及其权重，旨在制定冠心病热结血脉证相关诊断标准，为冠心病热结血脉证的临床诊疗和科学研究提供指导。

本文件由国家科技部重点基础研究发展计划（973计划）项目“中医证候临床辨证的基础研究”（项目编号：2014CB542900）和国家重点研发计划项目“冠心病等疾病痰瘀互结病因病机与诊治方案创新研究”资助。本文件由于受到受试者地域、民族、种族等因素的影响，在具体运用过程中，可依照实际情况而定。

CACM标准公示稿

冠状动脉粥样硬化性心脏病热结血脉证临床诊断标准

1 范围

本文件规定了冠心病热结血脉证的诊断依据和诊断原则。

本文件适用于全国二级及以上医疗机构及科研院所专业人员对冠心病热结血脉证的临床诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订版本）适用于本文件。

GB/T 16751.1-1997 中医临床诊疗术语-疾病部分

GB/T 16751.2-1997 中医临床诊疗术语-证候部分

WS 319-2010 冠状动脉粥样硬化性心脏病诊断标准

ZY/T 001.1-94 中医病症诊断疗效标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冠状动脉粥样硬化性心脏病 coronary atherosclerotic heart disease

冠状动脉粥样硬化性心脏病简称冠心病，是冠状动脉粥样硬化病变导致血管管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。

3.2

热结血脉 syndrome of heat retention in blood vessels

热邪与瘀血等有形之物在血脉中郁结难解，互为因果，出现积热、生毒、结癥、伤脉的不良循环过程。其主要病机是“热邪”与血脉中的“瘀血”“痰湿”等有形之物相互搏结，病位在“血脉”。总以清热解毒、活血凉血、散结养脉为治法。

3.3

胸闷 oppression in the chest

自觉胸中堵塞不畅、满闷不舒的表现。

3.4

胸痛 chest pain

胸部正中或偏侧作痛。

3.5

近期胸痛（闷）加重 chest pain (stuffy) aggravated recently

与四周前比较，做同等或类似强度的活动时，胸痛、胸部紧榨感和心绞痛的发作频率、程度及持续时间增加。

3.6

烦躁 dysphoria

心中烦闷不安，急躁易怒，甚则手足动作及行为举止躁动不宁的表现。

CACM标准公示稿

3.7

大便秘结　constipation

粪便干燥坚硬，排出困难，排便次数减少的表现。

3.8

口苦　bitter taste in mouth

自觉口中有苦味的表现。

3.9

口干　dry mouth

自觉口中津液不足，但没有饮水要求，或饮水很少的表现。

3.10

心悸　palpitation

感觉心脏跳动不安，常伴有心慌的表现。

3.11

舌红　red tongue

又称舌质红，舌质比正常的淡红色较深，主热证。

3.12

舌有瘀斑瘀点　ecchymosis on tongue

又称舌有瘀斑，是指舌上出现暗红、黑紫色或紫黑色斑点的舌象。舌面出现暗红或紫黑色斑点、斑块的舌象，反映体内有瘀血存在。

3.13

苔黄　yellow fur

又称黄苔，舌苔呈黄色的舌象，主热证，里证。

3.14

滑脉　slippery pulse

指脉象往来流行，应指圆滑，如珠走盘，主痰饮、食滞、实热等疾病。

3.15

数脉　rapid pulse

指脉来急速，一息五至以上（相当于每分钟 90 次以上）的脉象，多见于热证。

4　冠状动脉粥样硬化性心脏病热结血脉证临床诊断标准

本标准在系统回顾既往冠心病热相关证诊断标准的基础上，运用文献系统评价、定性访谈等方法，结合多轮研讨与论证，确立了冠心病热结血脉证临床诊断条目及其权重，制定了冠状动脉粥样硬化性心脏病热结血脉证临床诊断标准，具体见表1。

本标准适用人群首先应符合冠心病诊断，以下任何一项或多项者：

a）有明确的陈旧性心肌梗死病史；

b）曾行冠状动脉造影或冠状动脉CT血管造影（冠脉CTA）检查提示冠状动脉至少一支主要分支管腔直径狭窄≥50%；

CACM标准公示稿

c）曾接受冠状动脉血运重建治疗，包括经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention，PCI)或冠状动脉旁路移植术即冠状动脉搭桥术(coronary artery bypass grafting, CABG 简称冠脉搭桥术)。

表1 冠状动脉粥样硬化性心脏病热结血脉证临床诊断标准

指标层次	赋分	指标内容
主要指标	3 分/项	1.舌质红 2.苔黄 3.舌有瘀斑或瘀点 4.近期胸痛（闷）加重
次要指标	2 分/项	1.烦躁 2.大便秘结 3.滑脉 4.数脉
其他指标	1 分/项	1.口苦 2.口干 3.心悸
注 1：本文件的诊断原则：符合冠心病诊断，临床见上述指标累计赋分≥10 分者可诊断为冠心病热结血脉证。 注 2：同一条目中有多个症状或体征同时出现时（如胸痛、胸闷同时出现），仅按 1 项计分。 注 3：本标准推荐用于冠心病热结血脉证临床诊断，是否可用于干预措施的临床疗效评价有待研究。		

CACM标准公示稿

附录 A
（资料性）
附表 1 历年冠心病中医“热”相关证·辨证标准

时间	标准来源	热相关证	临床表现	舌象	脉象
1979	冠心病（心绞痛、心肌梗塞)中医辨证参考标准（1979 年修订）	偏热	无	苔黄腻	脉弦滑或滑数
1995	胸痹心悸（冠心病心律失常）中医急症诊疗规范	痰火扰心证	主症：胸闷、心悸、烦躁、心下痞满、失眠 兼证：口苦、口黏、痰黄稠、恶心	舌红苔黄腻	脉促或结代
2014	胸痹心痛络风内动证诊断专家共识	热毒生风	主症：突发胸痛、胸闷 次症：心悸、喘促、心烦、口渴、小便黄、便秘	舌红或青紫，舌苔黄腻或黄厚	脉弦滑数
2018	冠心病心绞痛证候要素诊断标准	热蕴	胸部灼痛、口干口苦、面红耳赤、大便干、小便黄、心烦失眠	舌红苔黄	脉数
2018	冠心病心绞痛主要证型的辨证诊断标准	热蕴	口干欲饮、面红耳赤、大便干、小便黄	舌红苔黄	无

CACM标准公示稿

参 考 文 献

[1] 中国心血管健康与疾病报告编写组.中国心血管健康与疾病报告 2019 概要[J].中华老年病研究电子杂志,2020,7(4):4-15.

[2] 国家卫生健康委员会.中国卫生健康统计年鉴 2020[M].北京：中国协和医科大学出版社，2020：290，296

[3] 张晓琦，宋耀鸿，姜艳，等.从“瘀热论”治疗冠心病[J].中西医结合心脑血管病杂志，2020，18(13):2172-2174.

[4] 陈胤峰，何庆勇，刘超，等.清热活血方剂干预冠心病心绞痛瘀热互结证临床观察[J].中华中医药杂志，2017，32(9):4288-4291.

[5] 么传为，李晓，等.冠心病(火邪热结证)辨证规律的研究[J].中国中医急症，2015，24(8):1360-1361，1364.

[6] 赵昕，王硕，齐文升.加味栀子大黄汤治疗热结血瘀证冠心病心绞痛 80 例临床观察[J].北京中医药，2010，29(10):775-776，806.

[7] 陈新宇，唐阿芳，谢海波，等.泻心胶囊对火邪热结型冠心病心绞痛的临床观察及对炎症因子干预作用[J].湖南中医药大学学报，2009，29(6):48-50.

[8] 张逸雯，胡镜清，杨燕.等“热结”的内涵与应用浅析[J].世界科学技术-中医药现代化，2019，21(10)：2013-2016.

[9] 胡镜清.“热结血脉”概论[J].世界科学技术-中医药现代化，2019，21(10).2005-2008.

[10] 张佳乐，张逸雯，许伟明，等.冠心病“热”相关证诊断要素文献分析[J].世界科学技术-中医药现代化，2019，21(10).2021-2026.

[11] 胡镜清，王传池，段飞,等. 冠心病痰瘀互结证宏观诊断标准研究[J].中国中西医结合杂志，2016，36(10):1164-1168.

[12] 胡镜清，许伟明，王传池,等. 冠心病痰湿证临床诊断标准解读[J].中国中医基础医学杂志，2017，23(9):1247-1252.

[13] 中华中医药学会.冠状动脉粥样硬化性心脏病痰湿证临床诊断标准[S].北京：中国中医药出版社，2017.

[14] 中华中医药学会.冠状动脉粥样硬化性心脏病痰瘀互结证临床诊断标准[S].北京：中国中医药出版社，2018.

[15] 中华中医药学会.基于病证结合的中医证临床诊断标准研制与应用规范[S].北京：中国中医药出版社，2020.

CACM标准公示稿